

腹壁韧带样瘤 84 例临床分析

董锐增, 师英强, 王春萌, 赵广法, 傅 红

(复旦大学附属肿瘤医院 复旦大学医学院肿瘤学系, 上海 200032)

摘要: [目的] 探讨腹壁韧带样瘤的临床特点 and 治疗方法。[方法] 回顾分析 1988 年 1 月~2007 年 12 月收治的 84 例腹壁韧带样瘤患者的临床资料, 其中首次治疗 69 例, 外院治疗后复发 15 例, 全组病例均经手术治疗, 5 例手术后有残留者给予术后放疗。[结果] 全组 84 例病例中, 79 例患者行广泛切除术, 5 例姑息性切除, 留有肉眼肿瘤残留。行广泛切除术者中, 73 例病理切缘阴性, 6 例病理切缘阳性, 其中 69 例首次治疗患者中, 64 例获得病理切缘阴性, 外院治疗后复发病例 15 例中, 5 例姑息性切除者皆留有肉眼肿瘤残留; 9 例病理切缘阴性。切缘阴性局部复发率 6.8%, 切缘阳性复发率为 33%。术后残留病例经放疗后, 2 例肿瘤消退, 1 例消退后 3 年复发再手术, 2 例稳定。[结论] 手术是治疗腹壁韧带样瘤的首要治疗方法, 首次治疗的正确性和获得病理切缘阴性对控制局部复发非常重要, 放疗是对手术不彻底的有效补充治疗手段。

关键词: 腹壁韧带样瘤; 外科手术; 放射疗法; 局部复发

中图分类号: R735.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-0242(2008)12-1079-03

Clinical Study of Abdominal Wall Desmoid Tumor: A Report of 84 Cases

DONG Rui-zeng, SHI Ying-qiang, WANG Chun-meng, et al.

(Cancer Hospital Affiliated to Fudan University, Shanghai 200032, China)

Abstract: [Purpose] To investigate the clinical features and treatment of the abdominal wall desmoid tumor. [Methods] Retrospective analysis was carried out in 84 cases with abdominal wall desmoid tumor between Jan. 1988 to Dec. 2007. Among them, 69 cases were primary treatment and 15 cases were retreated for recurrence after primary treatment in other hospitals. All the cases underwent surgery. Radiotherapy was administered to 5 cases with gross residual tumor. [Results] Seventy-nine cases underwent local wide resection and 5 palliative surgery. Of the 79 local wide excision cases, 73 cases were negative margins and 6 were positive; and 64 cases were negative margins in 69 initial treatment diseases and 9 cases in 15 recurrent diseases. Of the 5 cases with palliative surgery all had gross residual tumor. Local recurrences were 6.8% in negative margins and 33% in positive margins. Of the 5 patients with gross residual tumor, 2 cases were complete regression, 1 recurrent case underwent resurgery, and 2 cases were stable. [Conclusions] Surgery is the main treatment for abdominal wall desmoid tumor and radiotherapy is an important compensatory way for incomplete resection. Correct initial treatment and negative microscopic margin have magnitude significance for local recurrence. Radiotherapy is an added therapy for failure resection.

Key words: abdominal wall; desmoid tumor; surgery; radiotherapy; local recurrence

韧带样瘤 (desmoid tumor) 又称侵袭性纤维瘤病, 是一种发生于深部软组织的良性/交界性肿瘤, 常向邻近肌肉组织内浸润性生长, 腹壁是其好发部位之一, 治疗不彻底易复发。本院 1988 年 1 月~2007 年 12 月收治腹壁韧带样瘤病例 84 例, 现总结报告如下, 以加深对该病的认识。

收稿日期: 2008-04-22; 修回日期: 2008-07-03

通讯作者: 师英强

1 材料与方法

1.1 一般资料

1988 年 1 月~2007 年 12 月我院收治腹壁韧带样瘤 84 例, 均为术后病理明确诊断。其中男性 6 例, 女性 78 例, 男女比例 1:13, 年龄范围 16~64 岁, 平均年龄 32 岁, 发病高峰年龄为 25~35 岁 (61 例, 72.6%)。女性病人中 75 例为已婚患者, 其中 74 例

有生育史,16例有腹部手术史(包括剖宫产)。3例为家族性腺瘤病(FAP)患者,1例临床诊断为Lynch综合征,亦均为女性病人。4例为多发,1例合并腹外韧带样瘤。肿块位于下腹部72例(86%),位于上腹部12例。69例为首治病例,15例为外院切除后复发病例,复发时间2个月~10年不等。肿瘤大小2.5~25cm,其中3~8cm为最常见(68例,80%)。

临床表现均为腹部肿块,少数病例伴有隐痛不适,大多数病例肿块为稳定或者缓慢增大,仅3例复发病例肿块生长迅速,6~12个月肿瘤便生长至15~20cm,临床未见自发消退病例。

术前病人均行肿块B超检查,部分患者尤其是肿瘤较大者,行CT或MRI检查。B超表现为肌肉内低回声软组织肿块影,边界清楚或不清,血流一般不明显。CT平扫表现为肌肉等密度或稍高密度软组织肿块影,和肌肉关系密切,增强后病灶强化。MRI表现为肌肉内占位性病变,T1WI呈低信号或等信号,T2WI呈高信号。

术后标本均常规病理学检查,并标记切缘情况,部分肿瘤测激素受体表达情况。

1.2 治疗方法

本组病人均经过手术治疗,一般切缘距肿瘤尽可能3cm以上,所形成腹壁缺损,大多能直接缝合,缺损较大,无法直接修复者,早期采用涤纶补片,近5年采用进口Bard补片修复。肿瘤有残留和部分切缘阳性者,术后给予局部放疗,2Gy/次,放疗剂量50~60Gy。15例患者术后应用内分泌治疗(三苯氧胺)。

1.3 随访

随访资料来源于门诊复查信息和电话查询,随访自患者术后病理诊断明确开始,截止至2008年2月。

2 结果

病理学检查大体标本肿瘤质硬、灰白色、无包膜、边缘不规则,常位于肌肉内或与腱膜相连,部分病例侵犯腹膜,切面有纤维光泽。镜下肿瘤境界不清,常浸润周围软组织,特别是横纹肌,由增生的纤维母细胞和胶原纤维组成,不同区域两者比例不同,肿瘤细胞可有核分裂相,但无异常分裂相。17例行雌、孕激素受体测定者中9例雌激素和/或孕激素受体阳性。

全组84例患者中,79例行广泛切除术,5例因肿瘤累及髂血管行姑息性切除留有肉眼肿瘤残留。79例行广泛切除术中,73例(92%)病理切缘阴性,6

例(8%)病理切缘阳性,其中首次治疗患者中,64例(92.8%)获得病理切缘阴性,外院治疗后复发病例15例中,9例(60%)病理切缘阴性。随访4个月~20年,无死亡病例和远处转移病例。行广泛切除术患者中,7例复发(8.9%),其中切缘阴性局部复发5例(6.8%),切缘阳性2例复发(33%)。首治病例中病理切缘阳性3例,其中1例复发,另2例术后未采用任何治疗,分别随访15、20年,无复发;2例有残留。外院切除后复发病例再切除者3例切缘阳性,其中1例复发;3例有残留。5例有残留者术后均予放疗,2Gy/次,总剂量50~60Gy,3例肿瘤消退,其中1例先消退,但3年后复发,肿瘤5cm×2cm,再次手术切除,另2例随访8年,肿瘤无复发,2例肿瘤缩小稳定。7例复发患者,5例再次手术切除,2例给予放疗,其中1例放疗后再次手术切除。腹壁缺损采用涤纶补片和进口Bard补片者均未出现积液、感染、腹壁疝等并发症。

3 讨论

韧带样瘤具有局部侵袭性和复发倾向,文献报道其治疗后局部复发率高达20%~40%^[1]。好发生于年龄20~40岁的生育期妇女。

本病病因不是很清楚,鉴于患者多为育龄期妇女,大部分患者肿瘤组织有雌激素或孕激素受体表达,绝经后和卵巢切除后,肿瘤有自发消退报道^[2],提示本病的发生、发展可能与女性激素或激素平衡紊乱有关。患者多有生育史、剖宫产或其他腹部手术史,提示本病发生可能与肌肉损伤有一定关系。遗传因素也被证实与本病部分患者关系密切,1923年,Nichols描述了韧带样瘤与FAP的关系,本组病例中有4例有遗传背景,其中3例为FAP,1例临床诊断为Lynch综合征,这两种综合征分别与抑癌基因APC和错配修复基因突变有关。目前认为大约5%的韧带样瘤的发生与FAP相关,在FAP患者中,韧带样瘤发病率高达10%~25%,发病相对风险较一般人群高852倍,而Gardener's综合征患者同时发生该病的几率高达29%^[3-5]。FAP患者发生韧带样瘤时间大多在结肠术后1~2年,但也有在结肠手术之前发生,因此FAP和韧带样瘤的相互关系仍需进一步探讨^[6]。

临床表现为生长缓慢的实性肿瘤,一般多无症状。绝大多数患者发现后呈缓慢生长或保持稳定,部分病例肿瘤进展迅速,亦有自发消退的报告^[7],这种

生物学行为的不同表现目前还无法预测。Church 等^[7]报道,10%的韧带样瘤可以自发缩小,30%的患者呈现周期性的进展和缓解,50%患者在诊断后保持稳定,仅 10%病例进展迅速。Nakayama 等^[8]对 11 例诊断后未经任何治疗的韧带样瘤病人,经过平均近 6 年的随访(16 个月~11 年),10 例最终停止增长,3 例肿瘤缩小。本组病例在患者发现后仅 3 例复发病例肿瘤生长迅速,但未见自发消退病例。

手术治疗是腹壁韧带样瘤的主要治疗方法,腹壁韧带样瘤的复发率低于腹外和腹腔内韧带样瘤。手术治疗强调首次治疗的重要性,Spear 等^[2]报道显示手术治疗对原发和复发病例的 5 年局部控制率分别为 77%和 48%。鉴于本病有侵袭性生长和易于复发的特点,应尽可能广泛切除。对切缘组织学检查的意义仍有争论,大多数的研究均表明切缘状态是影响局部复发的重要因素之一,如 Nuyttens 等^[9]研究显示单纯手术治疗,切缘阴性局部控制率为 72%,切缘阳性仅为 41%,而 Reitamo 等^[10]提出肿瘤的生物学特性是影响肿瘤复发的重要因素。研究显示瘤细胞可浸润可触知肿瘤外围 2~3cm 组织,因此切缘应尽可能距肿瘤 3cm 以上,本组病例完整切除者,90%以上的病例获得病理组织学检查切缘阴性,因此切缘 2~3cm 以上基本是安全的。切缘阴性者复发率仅 6.8%(5/73),而切缘阳性者复发率高达 33.3%(2/6),首次手术者 92.8%(64/69)获得组织学切缘阴性,而复发病例仅 60.0%(9/15)获得组织学切缘阴性。因此首次治疗的正确性和尽可能获得病理切缘阴性对于病灶的局部控制是极其重要的。肿瘤切除后遗留腹壁缺损,因为大部分病人有生育史,腹壁较为松弛,腹壁缺损多可直接缝合,对于腹壁缺损大,不能直接缝合者,可用人工材料修复,或转移自体组织修复。

大多数研究结果显示放射治疗对韧带样瘤有效,有助于提高局部控制率。放疗被推荐用于术后有残留,切缘不足或肿瘤无法切除者,放疗剂量一般为 50~60Gy^[11]。Massachusetts General Hospital 研究显示单纯手术和手术+放疗的 5 年控制率对大体肿瘤有残留者分别为 50%和 59%,切缘阳性为 56%和 78%,切缘阴性为 77%和 100%^[12]。对于残留或不能切除的肿瘤,放疗后一般在 3 个月左右肿瘤开始缩小,放疗效应可持续数年。我们对 1 例术后复发再切除困难的患者先使用放疗后,肿瘤缩小后获得再手术机会,5 例残留病人给予放疗后,局部控制满意,并有 2 例长期无瘤生存,因此放射治疗对手术治疗不彻底有重要补充作用。

非甾体抗炎药舒林酸、雌激素受体拮抗剂三苯氧胺、干扰素、细胞毒药物等都曾使用于韧带样瘤,目前靶向药物格列卫也有试用于韧带样瘤的治疗报道^[13],因为发病率低,自然过程多种多样,目前缺乏随机对照试验,因此评价药物的疗效很困难。Zippel 等^[1]对于患者开始先予三苯氧胺或塞来考昔(Celebrex,西乐葆)治疗,以观察肿瘤的生物学行为,对于肿瘤保持稳定或缩小的,持续用药 1 年后停药,如肿瘤仍生长,给予辅助化疗、手术或放疗。

因此,对于腹壁韧带样瘤,目前是以手术治疗为主,放疗为补充的治疗模式,随着对肿瘤的自然病程的认识,以及对基因以及分子途径的研究的不断深入,相信在不远的将来,有望找出最合理的个体化治疗方法。

参考文献:

- [1] Zippel DB, Temple WJ. When is a neoplasm not a neoplasm? when it is a Desmoid[J]. J Surg Oncol, 2007, 95(3):190-191.
- [2] Spear MA, Jennings LC, Mankin HJ, et al. Individualizing management of aggressive fibromatoses [J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1998, 40(3):637-645.
- [3] Sturt JNH, Clark SK. Current ideas in desmoid tumors[J]. Fam Cancer, 2006, 5(3):275-285.
- [4] Gurbuz AK, Giardiello FM, Petersen GM, et al. Desmoid tumours in familial adenomatous polyposis[J]. Gut, 1994, 35(3): 377-381.
- [5] 袁志平, 宋永文, 李晔雄. 侵袭性纤维瘤病诊治进展[J]. 肿瘤学杂志, 2008, 14(3): 237-239.
- [6] 师英强, 莫善兢, 吴江宏, 等. 家族性腺瘤性息肉病伴纤维源性肿瘤的治疗[J]. 外科理论与实践, 2001, 6(5):339-340.
- [7] Church JM. Desmoid tumors in patients with familial adenomatous polyposis[J]. Semin Colon Rectal Surg, 1995, 6(1):29-32.
- [8] Nakayama T, Tsuboyama T, Toguchida J, et al. Natural course of desmoid-type fibromatosis[J]. J Orthop Sci, 2008, 13(1):51-55.
- [9] Nuyttens J, Rust P, Thomas C, et al. Surgery versus radiation therapy for patients with aggressive fibromatosis or desmoid tumors. A comparative review of 22 articles [J]. Cancer, 2000, 88(7):1517-1523.
- [10] Reitamo JJ, Scheinin TM, Häyry P. The desmoid syndrome. New aspects in the cause, pathogenesis and treatment of the desmoid tumor[J]. Am J Surg, 1986, 151(2): 230-237.
- [11] Schulz-Ertner D, Zierhut D, Mende U, et al. The role of radiation therapy in the management of desmoid tumors [J]. Strahlenther Onkol, 2002, 178(2):78-83.
- [12] Shih HA, Hornicek FJ, DeLaney TF, et al. Fibromatosis: current strategies for treatment [J]. Curr Opin Orthop, 2003, 14(6):405-412.
- [13] Janinis J, Patriki M, Vini L, et al. The pharmacological treatment of aggressive fibromatosis: a systematic review [J]. Ann Oncol, 2003, 14(2):181-190.